

2. A) Structure et philosophie de l'entretien neurologique

L'entretien neurologique a pour but de répondre à 4 grandes questions :

1. Y a-t-il une dysfonction du système nerveux ?
2. Où se situe cette dysfonction dans le système nerveux ?
3. Quelle est la cause de cette dysfonction ?
4. Comment la prendre en charge ?

Anamnèse

L'anamnèse neurologique suit les principes de toute anamnèse médicale :

- Le patient décrit ses symptômes
- L'information est complétée par des questions dirigées pour caractériser les symptômes et pour rechercher d'autres symptômes associés.
- L'anamnèse permet de faire des observations utiles pour l'examen neurologique (capacité d'attention, langage et parole, mouvements spontanés...).
- Il est souvent utile de compléter l'anamnèse auprès de l'entourage.
- L'anamnèse neurologique est complétée par les points habituels de l'anamnèse médicale.

Examen clinique

L'examen neurologique s'adapte aux découvertes faites durant l'anamnèse : un patient qui se plaint de fourmillements dans une main bénéficiera d'un examen très détaillé de la force et de la sensibilité, alors qu'un patient amené par ses proches pour des troubles de la mémoire sera principalement testé sur les fonctions cognitives.

L'examen peut se faire par grands systèmes : fonctions cognitives, fonctions motrices, fonctions sensorielles... ; ou par parties du corps : nerfs crâniens, membres supérieurs, tronc, membres inférieurs... ; ou encore une combinaison des deux. Il est important de développer une routine qui permette de s'habituer à pratiquer les manœuvres et à en interpréter les trouvailles.

Le déroulement des CC de Neurologie s'adapte à l'acquisition progressive des connaissances par les étudiants au cours de l'unité Neurosciences. C'est pourquoi l'ordre dans lequel sont enseignées les différentes parties de l'examen neurologique est un peu différent du déroulement habituel d'un tel examen :

1. Systèmes moteur et sensitif.
2. Examen de la nuque et de la colonne vertébrale.
3. Fonctions cognitives.
4. Nerfs crâniens.
5. Coordination, équilibre et démarche.

La dernière séance est l'occasion d'entraîner la pratique d'un examen neurologique « minimal » de dépistage. L'enseignant peut répartir les différents points à aborder de façon différente. L'accent doit être mis sur la pratique des gestes de l'examen clinique.

3. B) Systèmes moteur et sensitif

Anamnèse

Système moteur

- Faiblesse, fatigabilité, difficultés dans les mouvements fins.
- Atrophie musculaire ou fasciculations.

Système sensitif

- Hypoesthésie, anesthésie.
- Paresthésies. Douleurs.

Examen physique

Système moteur et réflexes

- Inspection : trophicité des muscles (atrophie ? possibilité de mesurer le diamètre du membre pour comparer à l'autre côté et pour le suivi), fasciculations ?
- Palpation : myalgies ?
- Percussion : réponse idiomusculaire (présente ? abolie ? augmentée ?), myotonie.
- Tonus : (sera revu au CC Neurologie 4)
 - Aux membres supérieurs et inférieurs.
 - Diminué (hypotonie) ? Augmenté (hypertonie) ?
 - Distinguer hypertonie spastique (pyramidale) et rigide (parkinsonienne)
- Force:
 - Peut être testée en théorie pour chaque mouvement de chaque articulation.
 - Chaque mouvement teste préférentiellement un muscle (ou quelques-uns), innervé par une (ou quelques) racine spinale (concept de myotome) et un nerf périphérique (concept de territoire d'innervation).
 - Contrebalancer la force du patient en utilisant un groupe musculaire de force équivalente ou similaire.
 - Comparer avec le côté controlatéral, proximal vs. distal.
 - Cotation de la force (échelle « Medical Research Council ») :
 - M0. Aucune contraction musculaire visible
 - M1. Contraction musculaire visible, mais aucun mouvement.
 - M2. Mouvement possible une fois la gravité éliminée (p.ex. dans le plan du lit).
 - M3. Mouvement contre gravité possible, mais pas contre résistance.
 - M4. Mouvement contre résistance possible, mais pas assez de force pour considérer comme normal.
 - M5. Force normale.
 - Savoir tester au moins :
 - Membres supérieurs : abduction de l'épaule (C5), flexion (C6) et extension (C7) du coude, flexion dorsale du poignet (C8), extension et abduction des doigts (T1).
 - Membres inférieurs : flexion (L2) et abduction de la hanche, flexion et extension (L4) du genou, flexion dorsale (L5) et plantaire (S1) de la cheville, inversion et éversion du pied, flexion dorsale et plantaire de l'hallux.
 - Tests globaux de la force :
 - Membres supérieurs : épreuve des bras tendus.
 - Membres inférieurs : épreuve de Mingazzini, épreuve de Barré.
- Réflexes ostéo-tendineux (ROTs) :
 - Peuvent être recherchés en théorie pour chaque tendon.
 - Manœuvres de renforcement : Jendrassik (pour les ROTs des membres inférieurs), serrer les dents (pour les ROTs des membres supérieurs).
 - Comparer avec le côté controlatéral.
 - Cotation :
 - 0. Réflexe absent (0)
 - 1. Réflexe faible (ou obtenu uniquement avec renforcement) (+)

- 2. Réflexe normovif (++)
- 3. Réflexe hypervif avec extension de la zone réflexogène, diffusion (+++)
- 4. Réflexe hypervif (avec clonus et réflexe cutané plantaire extension) (++++)
- Savoir tester au moins :
 - Membres supérieurs : bicipital (C5), stylo-radial (C6), tricipital (C7) et cubito-pronateur ou palmaire (C8).
 - Membres inférieurs : rotulien (L4), achilléen (S1).
- Signe de Hoffmann : exagération du ROT fléchisseur des doigts.
- Réflexes cutanés :
 - Réflexe cutané plantaire : normal en flexion ; en extension = signe de Babinski
 - Réflexes cutanés abdominaux (absents en cas d'atteinte pyramidale)

En fonction des trouvailles de l'examen du système moteur, il faut distinguer :

- Une atteinte centrale (syndrome pyramidal) d'une atteinte périphérique.
- En fonction de la distribution de la parésie : localisation de la lésion dans le système nerveux central (hémisphères, tronc cérébral, moelle épinière) ou périphérique (racine spinale, nerf périphérique, jonction nerf-muscle ou muscle).

Système sensitif

De préférence, tester:

- Sensibilité tactile superficielle :
 - Toucher léger (p.ex. avec les extrémités des doigts).
 - Comparer avec le côté controlatéral, proximal vs. distal.
 - Avoir en tête la distribution des dermatomes et des territoires d'innervation des nerfs périphériques pour guider l'examen.
- Sensibilité thermo-algique :
 - Sensibilité à la piqûre (p.ex. avec un abaisse-langue ou un coton-tige qu'on casse).
 - Sensibilité à la douleur profonde (p.ex. pincer le lit de l'ongle ou le tendon achilléen) : utile pour estimer l'état de vigilance.
 - Sensibilité au chaud (p.ex. remplir un tube d'examen avec de l'eau chaude, mais pas brûlante) et au froid (p.ex. tube d'examen rempli d'eau froide, ou instruments d'examen en métal).
- Sensibilité profonde :
 - Sens des positions :
 - Détection de mouvements passifs du pouce / du gros orteil.
 - Recherche du pouce.
 - Sensibilité vibratoire (pallesthésie) :
 - Avec le diapason orthopédique (coté /8).
 - Comparer avec le côté controlatéral, proximal vs. distal, membres inférieurs vs. supérieurs.
- Sensibilité discriminative : (sera revue en partie au CC Neurologie 2)
 - Discrimination de deux stimuli tactiles rapprochés (« two-point discrimination »).
 - Discrimination de formes, de textures.
 - Topesthésie (capacité de localiser un stimulus tactile sur le corps).
 - Stéréognosie (capacité de reconnaître un objet par le toucher ; utiliser p.ex. un trombone à papier et une épingle à nourrice).
 - Graphesthésie (capacité de reconnaître des chiffres et des lettres tracés sur la pulpe des doigts).

4. C) Examen de la nuque et de la colonne vertébrale

Nuque et signes méningés

- Raideur de nuque ?
- Signes de Kernig et de Brudzinski.
- Auscultation carotidienne : souffle ? (sténose carotidienne)

Colonne vertébrale

- Inspection : déformation, scoliose, hyperlordose, hypercyphose ?
- Mobilité : manœuvre de Schober, distance doigts-sol.
- Manœuvre de Lasègue : recherche d'une reproduction de la douleur radiculaire à l'élévation passive du membre impliqué (plus sensible) ou du membre controlatéral (plus spécifique).

2. Déroulement de la session

Anamnèse

L'anamnèse recherche des difficultés avec les fonctions suivantes :

- Attention et concentration
- Langage (parlé et écrit)
- Mémoire (oublis d'informations récentes ? rendez-vous manqués ? suivi de l'actualité ?)
- Calcul
- Modifications du caractère et du comportement (irritabilité ? changement dans les intérêts ou les loisirs ?)

Il est utile d'interroger le patient sur son autonomie dans les activités instrumentales de la vie quotidienne :

- Déplacements quotidiens
- Courses et préparation des repas
- Habillage
- Ménage
- Communication
- Gestion administrative et des médicaments
- Conduite automobile

Il est aussi important d'évaluer la présence de symptômes anxieux ou dépressifs concomitants (p.ex. à l'aide d'un questionnaire de dépistage).

Il peut être crucial de compléter l'anamnèse avec les proches aidants, car le patient peut ne pas être conscient de l'étendue de ses difficultés cognitives.

Examen clinique

Latéralité (gaucher ou droitier)

Attention et concentration

- L'attention est déjà évaluée durant l'anamnèse : le patient est-il capable de soutenir la conversation ?
- Empan numérique à l'endroit (au moins 5 chiffres) et à l'envers (au moins 3 chiffres).
- Attention soutenue : « A-test ».
- Soustractions de 7 en série : « 100 – 93 – 86 – 79 – 72 – 65 ».
- Epellation de mots à l'envers (par ex. "monde").

Orientation spatiale et temporelle

Fonctions exécutives

- Raisonnement abstrait :
 - Conceptualisation (similitudes entre objets).
 - Histoires absurdes.
- Flexibilité mentale : fluence verbale (grapho-phonémique).
- Sensibilité aux interférences et inhibition des réponses automatiques :
 - Consignes contradictoires.
 - « Go-no go ».
- Programmation et exécution de séquences motrices :
 - Séquence motrice de Luria.
 - Frises de Luria.
- Dépendance à l'environnement : comportement d'utilisation, grasping.
- Réflexes archaïques :
 - Grasping.
 - Naso-palpébral.
 - Palmo-mentonnier.
 - Moue.
 - Succion.

Langage

- Expression orale:
 - Fluidité de l'expression spontanée.
 - Dénomination d'objets.
 - Présence de paraphasies (mot pour un autre) sémantiques (« table pour chaise ») ou phonémiques (« tare pour barre »).
- Compréhension orale:
 - Adéquation des réponses aux questions posées.
 - Exécution de consignes motrices simples (« Tirez la langue ») ou complexes (avec 3 étapes).
- Lecture:
 - Lecture à voix haute.
 - Exécution de consignes motrices écrites (« Fermez les yeux »).
 - Résumé d'un bref texte écrit.
- Ecriture : faire écrire une phrase complète (avec sujet, verbe et objet).

Praxies

- Imitation de gestes sans signification.
- Pantomime d'utilisation d'objets.
- Praxies constructives : dessin de figures géométriques, copie du cube de Necker.
- Habillage.

Gnosies et capacités visuo-spatiales

- Gnosies visuelles : reconnaissance des objets par la vision.
- Gnosies tactiles :
 - Stéréognosie : reconnaissance des objets par le toucher.
 - Graphesthésie : reconnaissance de chiffres ou lettres tracés sur la peau.
- Capacités visuo-spatiales : rechercher une hémiparésie...
 - Détection de cibles.
 - Bissection de lignes.
 - Extinction visuelle ou tactile.

Mémoire

- Mémoire de travail : testée avec l'empan verbal.
- Mémoire déclarative verbale : encodage et restitution d'une liste de mots.
- Mémoire déclarative visuo-spatiale :
 - Test des 3 objets.
 - Copie d'un dessin de mémoire.
- Mémoire déclarative autobiographique : testée avec l'aide des proches aidants.
- Mémoire déclarative sémantique : connaissances générales (p.ex. « Quelle est la capitale de l'Italie ? »).

2. Déroulement de la session

Anamnèse

- I :
 - Hyposmie, anosmie, dysosmie.
- II :
 - Baisse d'acuité visuelle.
 - Désaturation des couleurs.
 - Scotome.
 - Amaurose fugace.
 - Amputation du champ visuel.
 - Douleur aux mouvements oculaires.
- III-IV-VI :
 - Diplopie, vision trouble.
 - Ptose palpébrale, asymétrie des fentes palpébrales.
- V :
 - Hypoesthésie, paresthésies, dysesthésies.
 - Faiblesse de la mastication.
 - Douleurs de la face (névralgie du trijumeau).
- VII :
 - Asymétrie de la face, sialorrhée.
 - Hypogueusie, agueusie, dysgueusie.
- VIII :
 - Hypoacousie, surdité.
 - Acouphènes.
 - Vertige.
- IX-X :
 - Dysarthrie, dysphonie, dysphagie (fausses routes ?).
- XI :
 - Faiblesse de l'élévation de l'épaule.
- XII :
 - Atrophie et diminution de la mobilité de la langue.

Examen physique

En préambule, il est important de considérer que l'atteinte clinique d'une fonction "crânienne" n'est pas nécessairement due à une atteinte d'un nerf crânien. Par exemple, une parésie faciale dans le contexte d'une lésion cérébrale hémisphérique est secondaire à une atteinte de la voie corticospinale mais ne signifie pas que le 7ème nerf crânien (nerf facial) soit touché. De ce fait, même si cela est habituellement observé dans les rapports, mentionner une telle parésie faciale sous la rubrique "nerfs crâniens" est techniquement incorrect. Il est préférable de raisonner et documenter les trouvailles cliniques en termes de syndromes (par exemple, hémisyndrome moteur droit incluant la face et le bras).

- I :
 - Substances odorantes (éviter les irritants, le menthol). Tester chaque narine séparément.
- II :
 - Acuité visuelle (avec les lunettes) : lecture à 30 cm. Tester chaque œil séparément.
 - Réflexe pupillaire : direct et consensuel et à la convergence.
 - Déficit pupillaire afférent relatif (RAPD).

- Champ visuel par confrontation : tester chaque œil séparément.
- Examen du fond d'œil avec l'ophtalmoscope direct
- III-IV-VI :
 - Position des yeux (déviation du regard ?). Parallélisme des axes visuels (strabisme ?).
 - Motricité dans les 4 directions cardinales (diplopie, nystagmus ?).
 - Nystagmus optocinétique.
 - Ptose palpébrale, asymétrie des fentes palpébrales.
 - Test de Simpson : maintien prolongé de l'ouverture des yeux et du regard vers le haut (myasthénie ?)
- V :
 - Sensibilité tactile superficielle et thermo-algique des 3 territoires.
 - Force des masticateurs : serrer les dents (palper les muscles de la mastication), mordre sur un abaisse-langue. Mouvements latéraux de la mâchoire. Asymétrie de l'ouverture de la bouche (signe d'atteinte unilatérale) ?
 - Réflexe cornéen : direct et consensuel.
 - Réflexe massétérin (un réflexe ostéo-tendineux).
- VII :
 - Mimique faciale spontanée (symétrie des commissures labiales, plis nasogéniens, plis du front).
 - Fermeture forcée des yeux : observation du phénomène de Bell, recherche du signe des cils de Souques.
 - Plisser le front.
 - Gonfler les joues.
 - Grimace montrant les dents : rechercher la contraction du platysma.
 - Différencier une paralysie faciale périphérique d'une atteinte centrale : motricité faciale volontaire (sur consigne) vs. automatique (spontanée) ; la parésie inclut la moitié supérieure de la face dans une atteinte périphérique
 - Penser à examiner le conduit auditif externe en cas de paralysie faciale périphérique (vésicules herpétiques, syndrome de Ramsay-Hunt).
 - Le goût ne se teste pas de routine.
- VIII :
 - Voix chuchotée (tester chaque oreille en masquant l'autre), voix haute si échec.
 - Epreuves de Rinne et Weber.
 - Nystagmus spontané (lunettes de Frenzel : permettent d'inhiber la fixation et faire apparaître un nystagmus vestibulaire).
 - Manœuvre de Hallpike (vertige paroxystique positionnel bénin ?).
 - Marche à l'aveugle, épreuve d'Unterberger (déviation ?).
- IX, X :
 - Phonation (voix bitonale ? voix nasonnée ? aphonie ?).
 - Déglutition.
 - Voile du palais, au repos et à la phonation (signe du rideau).
 - Réflexe nauséux.
- XI :
 - Faiblesse de l'élévation de l'épaule (partie supérieure du trapèze) et de la rotation de la tête (sterno-cléido-mastoïdien).
 - La flexion de la nuque contre résistance teste les deux sterno-cléido-mastoïdiens en même temps.
- XII :
 - Trophicité de la langue (atrophie ? fasciculations ?).
 - Protrusion de la langue, mouvements latéraux.

2. A) La coordination, l'équilibre et la marche

Anamnèse

- Symptômes liés à une dysfonction cérébelleuse : dysarthrie, troubles de la déglutition, vertiges, maladresse, troubles de l'équilibre et de la marche.
- Symptômes liés à une dysfonction des ganglions de la base : lenteur et rareté des mouvements, tremblement, autres mouvements involontaires remarqués par le patient, lenteur de la marche.
- Troubles de l'équilibre : sensation d'instabilité (parfois décrite comme un vertige), chutes ?
- Troubles de la marche : boiterie ? lenteur ? douleur ? (claudication neurogène)

Examen physique

Nerfs crâniens

- Motricité oculaire : nystagmus ? skew deviation ?
- Réflexe nasopalpébral : inépuisable ?
- Mimique et motricité faciale : rareté du clignement ? expression figée ?
- Articulation : répéter rapidement des syllabes sans signification (p.ex. « pa-ta-ka »).

Membres

- Observation : tremblement ? mouvements involontaires ou postures anormales ? (chorée, dystonie)
- Tonus : hypotonie ? manœuvre de Stewart-Holmes. Hypertonie rigide ? manœuvre de Froment.
- Réflexes ostéo-tendineux : réflexe rotulien pendulaire ? (hypotonie)
- Diadococinésie (mouvements rapides alternés) : marionnettes, ouverture et fermeture rapide du poing, tapotement alterné du pouce contre l'index.
- Capacité à battre la mesure en rythme.
- Epreuve doigt-nez (et doigt-nez-doigt) : dysmétrie ? tremblement d'intention ?
- Epreuve talon-genou : dysmétrie ? tremblement d'intention ?

Equilibre et démarche

- Station debout : anomalie de la posture ? Elargissement du polygone de sustentation ?
- Station debout pieds joints, position en tandem : maintien de l'équilibre ?
- Accroupissement : les talons doivent normalement décoller du sol.
- Marche : boiterie ? vitesse ? ballant des bras ? demi-tour (décomposé) ?
- Marche sur les talons et les pointes des pieds, appui et sautillement sur un pied : bons tests globaux de la force des membres inférieurs et de l'équilibre.
- Marche du funambule.

Manœuvres liées à l'équilibre et à la marche

- Manœuvre de Romberg : augmentation de l'instabilité à la fermeture des yeux ? (teste les fonctions proprioceptive et vestibulaire)
- Manœuvre d'Unterberger (et marche à l'aveugle) : déviation ? (teste la fonction vestibulaire)

3. B) Examen neurologique de dépistage

Un examen neurologique de dépistage (screening) est présenté ci-dessous. Il s'agit du « minimum vital » à faire chez un patient chez qui l'anamnèse n'a pas relevé de symptômes neurologiques

Niveau de vigilance

Fonctions cognitives

- Capacité d'attention, orientation spatiale et temporelle.
- Langage : compréhension et expression orales (durant l'anamnèse), dénomination.
- Fonctions visuo-spatiales : négligence.
- Mémoire.

Nerfs crâniens

- II:
 - Champ visuel par confrontation.
 - Fond d'œil.
- III, IV, VI :
 - Motricité oculaire, nystagmus.
 - Fentes palpébrales.
 - Pupilles : forme et symétrie.
 - Réflexe pupillaire à la lumière.
- VII :
 - Mimique et motricité faciale.
- IX, X :
 - Voile du palais, au repos et à la phonation.
 - Articulation, phonation (testées durant l'anamnèse).
- XII :
 - Langue, au repos et à la protrusion.

Nuque

- Signes méningés

Membres supérieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve des bras tendus.
- Réflexes ostéo-tendineux : bicipital, tricipital, stylo-radial.
- Diadococinésie.
- Sensibilité tactile superficielle.
- Epreuve doigt-nez.

Tronc

- Sensibilité tactile superficielle : niveau sensitif ?

Membres inférieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve de Mingazzini.
- Réflexes ostéo-tendineux : rotulien, achilléen.
- Réflexe cutané plantaire.
- Sensibilité tactile superficielle.
- Pallesthésie aux extrémités inférieures.
- Epreuve talon-genou.

Equilibre et démarche

- Station debout, pieds joints, yeux ouverts puis fermés (épreuve de Romberg).
- Marche (symétrie des pas, ballant des bras, demi-tour).
- Marche sur les pointes des pieds et les talons, appui et sautillonnement sur un pied.
- Position du tandem, marche du funambule

1. Réflexes des membres supérieurs

En complément à l'examen neurologique du cahier de l'unité, l'examen clinique est illustré par des photographies (© [A. Kohler](#)). Il s'agit d'un examen standard. Cette illustration concerne l'examen des réflexes et celui de la force. Les réflexes les plus importants à connaître sont décrits. Le testing de la force montre la façon de tester les muscles ou les groupes musculaires les plus importants.

La façon de tester est adaptée pour un patient couché. Il existe parfois d'autres façons d'examiner la force.

Cette ressource de type Livre est composée de 4 pages. On y accède par la [table des matières](#) qui s'affiche à droite de ce contenu mais qui peut être aussi positionnée au bas de chacune des page si la largeur de la fenêtre de votre navigateur est insuffisante.

Bicipital

Racine: C6



Tricipital

Racine: C7



Stylo-radial

Racine: C6



Cubito-pronateur

Racine: C8



2. Réflexes des membres inférieurs

Rotulien

Racine: L4



Achilléen

Racine: S1



Note

Lors d'une hyperréflexie, rechercher une extension de la zone réflexogène, un polycinétisme, un clonus.

Lorsque l'on n'obtient pas de réflexe, ou un réflexe très faible, on peut pratiquer des manoeuvres de facilitation (par exemple manoeuvre de Jendrassik).

Photos: [A. Kohler](#)

3. Force des membres supérieurs

Deltoïde

- Mouvement: Flexion = antépulsion de l'épaule
- Muscle: Deltoïde
- Nerf: Circonflexe (= axillaire)
- Racine: C5-C6
- Commentaire: Le patient élève le membre supérieur. Contre-résistance appliquée par l'examineur: vers le bas.



Biceps

- Mouvement: Flexion du bras
- Muscle: Biceps
- Nerf: Musculo-cutané
- Racine: C5-C6



Triceps

- Mouvement: Extension du bras
- Muscle: Triceps
- Nerf: Radial
- Racine: C5-**C7**-C6

- Commentaire: Il est possible de tester le triceps en partant d'une position fléchie du bras, et en demandant de l'étendre contre résistance.



Radiaux et cubital postérieur

- Mouvement: Extension du poignet
- Muscle: Radiaux et cubital postérieur
- Nerf: Radial
- Racine: C6-C7



Fléchisseurs profond et superficiel, interosseux

- Mouvement: Flexion des doigts
- Muscle: Fléchisseurs profond et superficiel, interosseux
- Nerf: Cubital et médian
- Racine: C7-C8-D1
- Commentaire: Teste de façon globale tous les fléchisseurs des doigts; selon la pathologie, tester de façon plus détaillée.



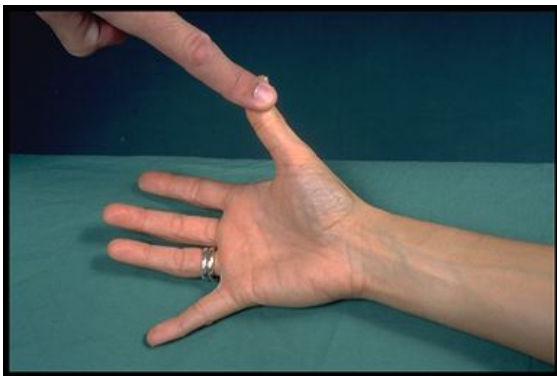
Interosseux dorsaux

- Mouvement: Abduction des doigts
- Muscle: Interosseux dorsaux
- Nerf: Cubital
- Racine: C7-C8-D1



Court abducteur du pouce

- Mouvement: Elévation du pouce dans un plan vertical, la main restant dans un plan horizontal
- Muscle: Court abducteur du pouce
- Nerf: Médian
- Racine: C7-C8-D1



4. Force des membres inférieurs

Psoas-iliaque

- Mouvement: Flexion de la hanche
- Muscle: Psoas-iliaque
- Nerf: Crural (= fémoral)
- Racine: L2-L3-L4



Moyen fessier

- Mouvement: Abduction de la hanche
- Muscle: Moyen fessier
- Nerf: Fessier supérieur
- Racine: L4-S1
- Commentaire: Le patient fait une abduction contre résistance de l'examineur



Adducteurs

- Mouvement: Adduction de la hanche
- Muscle: Adducteurs
- Nerf: Obturateur
- Racine: L2 à S1
- Commentaire: Le patient fait une adduction contre résistance de l'examineur



Grand fessier (+ participation des ischio-jambiers)

- Mouvement: Extension de la hanche
- Muscle: Grand fessier (+ participation des ischio-jambiers)
- Nerf: Fessier inférieur
- Racine: L5-S1-S2
- Commentaire: Le patient appuie contre le bas, contre résistance de l'examineur



Quadriceps

- Mouvement: Extension du genou
- Muscle: Quadriceps
- Nerf: Crural (=fémoral)
- Racine: L2-L3-L4
- Commentaire: Le quadriceps est un muscle très fort. Une parésie légère ou modérée ne sera pas mise en évidence par le testing manuel. Il faut alors faire monter le patient sur un escabeau ou un tabouret.



Ischio-jambiers

- Mouvement: Flexion du genou
- Muscle: Ischio-jambiers
- Nerf: Branches du sciatique
- Racine: L5-S1-S2



Jambier antérieur

- Mouvement: Relever le pied
- Muscle: Jambier antérieur
- Nerf: SPE
- Racine: L4-L5
- Commentaire: En station debout, une bonne façon de tester les releveurs du pied est de faire marcher le patient sur les talons.



Triceps sural

- Mouvement: Flexion plantaire du pied
- Muscle: Triceps sural
- Nerf: SPI
- Racine: S1-S2
- Commentaire: En station debout, une bonne façon de tester les fléchisseurs du pied est de faire marcher le patient sur la pointe des pieds.



Jambier postérieur

- Mouvement: Inversion du pied
- Muscle: Jambier postérieur
- Nerf: SPI
- Racine: L5-S1



Péroniers latéraux

- Mouvement: Eversion du pied
- Muscle: Péroniers latéraux
- Nerf: SPE
- Racine: L5-S1



Extenseur commun, pédieux, extenseur propre du gros orteil

- Mouvement: Extension des orteils
- Muscle: Extenseur commun, pédieux, extenseur propre du gros orteil
- Nerf: SPE
- Racine: L5-S1



Photos: [A. Kohler](#).